

1. Introducción y relevancia clínica

La **laringitis aguda**, conocida también como **crup viral**, es una **infección inflamatoria aguda de la laringe** (especialmente la región subglótica), que provoca **obstrucción variable de la vía aérea superior**.

Se caracteriza por el clásico “**estridor inspiratorio, tos perruna y disfonía**”, especialmente en niños pequeños.

Epidemiología

- Afecta principalmente a **niños entre 6 meses y 5 años**, con pico entre los 18 meses y 2 años.
- Es más frecuente en **otoño e invierno**.
- Representa cerca del **15% de las consultas pediátricas por dificultad respiratoria**.
- Rara en adultos, donde se asocia más a irritantes o sobreuso vocal.

Relevancia clínica

- Es una causa **muy frecuente de urgencia respiratoria pediátrica**.
- Aunque la mayoría de los casos son leves, un pequeño porcentaje puede evolucionar a **obstrucción grave de la vía aérea**.
- En el EUNACOM, es una de las **preguntas más recurrentes**, por su diagnóstico clínico, manejo escalonado y criterios de hospitalización.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía funcional

La **laringe** del niño es más pequeña, más alta (a nivel de C3–C4) y el **anillo cricoideo** representa el punto más estrecho de la vía aérea.

Cualquier edema subglótico produce **aumento proporcionalmente mayor de la resistencia al flujo aéreo**, debido a que el radio del lumen disminuye en forma significativa (Ley de Poiseuille: la resistencia es inversamente proporcional al radio⁴).

2.2 Fisiopatología del crup viral

1. Infección viral (habitualmente por **Parainfluenza tipo 1 y 2**) → inflamación de mucosa laríngea y subglótica.
 2. Edema y exudado → **estrechamiento del lumen** en la región subglótica.
 3. Turbulencia del flujo aéreo durante la inspiración → **estridor inspiratorio**.
 4. Irritación de cuerdas vocales → **disfonía y tos perruna**.
 5. En casos graves: hipoxia, retención de CO₂ y fatiga respiratoria.
-

2.3 Etiología

Tipo	Agentes principales	Comentarios
Viral (más común)	Parainfluenza (1–2–3), Influenza A/B, Virus sincicial respiratorio (VSR), Adenovirus, Sarampión	Responsable del 90% de los casos.
Bacteriano (raro)	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus pyogenes</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	Forma grave conocida como crup bacteriano o traqueítis bacteriana .
No infeccioso	Alergias, reflujo laringofaríngeo, intubación prolongada, irritantes	Menos frecuente.

2.4 Clasificación según severidad (Westley Score modificado)

Grado	Estridor	Tos perruna	Entrada de aire	Tiraje	Cianosis
Leve	Solo al llanto	Presente	Normal	Ausente o leve	No
Moderado	En reposo	Presente	Disminuida	Subcostal/intercostal	No
Grave	Intenso en reposo	Tos débil o ausente	Marcadamente disminuida	Tiraje generalizado	Puede haber
Amenaza vital	Estridor puede desaparecer (flujo mínimo)	Tos ausente	Ausente	Fatiga, letargia	Frecuente

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Cuadro clínico típico

- **Inicio precedido por síntomas catarrales** (coriza, fiebre baja, rinorrea).
- Evolución en horas a:
 - **Tos perruna** (seca, metálica).
 - **Disfonía o voz ronca**.
 - **Estridor inspiratorio**, inicialmente solo al llanto, luego en reposo.
 - **Dificultad respiratoria variable**.
 - En casos moderados a graves: tiraje subcostal, aleteo nasal, agitación o cianosis.

3.2 Examen físico

- Niño ansioso, inquieto, sentado (posición de olfateo).
- **Estridor inspiratorio** audible.
- **Tiraje** y uso de músculos accesorios.
- **Saturación de O₂** generalmente >90% en casos leves-moderados.
- **Sin sialorrea ni disfagia marcada** (diferencial con epiglotitis).
- **Faringe** sin exudado purulento (diferente de amigdalitis bacteriana).

3.3 Diagnóstico diferencial

Patología	Diferencias clave
Epiglotitis aguda (Hib)	Inicio brusco, fiebre alta, sialorrea, voz apagada, posición de trípode, ausencia de tos perruna. ¡Emergencia!
Traqueítis bacteriana	Fiebre alta, aspecto tóxico, estridor + secreciones purulentas, mala respuesta a adrenalina nebulizada.
Reacción alérgica/angioedema	Edema facial, urticaria, historia de exposición.
Cuerpo extraño laríngeo	Inicio súbito, sin fiebre, estridor persistente unilateral.
Absceso retrofaríngeo	Tortícolis, dolor cervical, abombamiento posterior faríngeo.

☐ **Diferenciar crup viral de epiglotitis** es fundamental:
 el niño con **crup ladra y tose**, el de **epiglotitis babea y no tose**.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Diagnóstico clínico

El diagnóstico de **laringitis aguda / crup viral es clínico**.

No se requieren estudios en la mayoría de los casos.

Exámenes complementarios (solo en casos atípicos o graves):

Examen	Utilidad
Oximetría de pulso	Evaluar saturación y progresión.
Radiografía lateral de cuello	Solo si diagnóstico incierto. Puede mostrar signo del “campanario” o “steeple sign” (estrechamiento subglótico).
Hemograma / PCR	No rutinario; útil si sospecha de infección bacteriana.
Cultivo viral / aspirado nasal	No indicado en manejo agudo.
Laringoscopia directa	Contraindicada en fase aguda (riesgo de laringoespasma).

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El manejo depende de la severidad. Todos los casos requieren:

- **Ambiente tranquilo** (el llanto agrava el estridor).
 - **Oxigenoterapia** solo si saturación <92%.
 - **No manipular innecesariamente la vía aérea.**
 - **Monitorización y observación** tras tratamiento inicial.
-

5.1 Tratamiento farmacológico

Corticoides (pilar del manejo)

- Reducen edema subglótico y duración de síntomas.
- Efecto comienza a las 2–3 horas y dura hasta 24–48 h.

Opciones:

- **Dexametasona oral o IM:** 0,15–0,6 mg/kg dosis única (máx. 12 mg).
- **Prednisona oral:** 1–2 mg/kg dosis única (si no hay dexametasona).
- **Budesonida nebulizada:** 2 mg dosis única, útil si no tolera VO.

Todos los pacientes con crup (leve, moderado o grave) deben recibir **corticoide**.

Adrenalina nebulizada (epinefrina racémica o L-adrenalina)

- Indicada en **casos moderados o graves** (estridor en reposo, tiraje moderado-grave).
- Produce **vasoconstricción subglótica rápida** → mejora en minutos, efecto dura 1–2 horas.

Dosis:

- Adrenalina L (1:1000): 0,5 mL/kg (máx. 5 mL) nebulizada con O₂ .
 - Observar al menos 2–3 horas después por riesgo de “rebote”.
 - Puede repetirse si reaparecen síntomas.
-

Antibióticos

- **No indicados en crup viral.**
 - Solo si sospecha **traqueítis bacteriana o sobreinfección**.
-

Antipiréticos y medidas generales

- Paracetamol o ibuprofeno según necesidad.
- Evitar antitusivos y descongestionantes.
- Mantener hidratación y reposo.

5.2 Manejo según severidad

Grado	Tratamiento
Leve	Dexametasona VO; observación 2 h; alta con educación a padres.
Moderado	Dexametasona VO/IM + adrenalina nebulizada; observación hospitalaria 6–12 h.
Grave	Adrenalina nebulizada inmediata + dexametasona IM; considerar hospitalización y eventual intubación.
Amenaza vital	Manejo avanzado de vía aérea (anestesia/ORL), adrenalina nebulizada continua, traslado a UCI.

5.3 Criterios de hospitalización (MINSAL / SOCHIORL)

- Estridor en reposo persistente después de adrenalina.
- Tiraje moderado o grave.
- Hipoxemia ($\text{SatO}_2 < 92\%$).
- Mala respuesta a corticoides.
- <12 meses o comorbilidad respiratoria/cardíaca.
- Requerimiento de >2 dosis de adrenalina.
- Diagnóstico incierto o sospecha de traqueítis bacteriana.

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones

- **Obstrucción severa de la vía aérea.**
- **Hipoxemia / insuficiencia respiratoria.**
- **Traqueítis bacteriana secundaria (*S. aureus*).**
- **Neumonía viral o bacteriana concomitante.**
- **Deshidratación** (por dificultad para beber).
- **Raramente muerte**, si manejo tardío.

6.2 Pronóstico

- **Excelente** con tratamiento adecuado.
- Duración promedio: 3–7 días.
- Recurrencias posibles (15–20%), especialmente en niños con antecedentes alérgicos o reflujo.
- No deja secuelas estructurales en la vía aérea.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Triada clásica:** estridor inspiratorio + tos perruna + disfonía.
2. **Siempre administrar corticoides**, incluso en cuadros leves.
3. **Adrenalina nebulizada** produce mejoría rápida, pero transitoria.

4. **No usar antibióticos** en crup viral típico.
 5. **No manipular la vía aérea** ni realizar laringoscopia innecesaria.
 6. Niño con **sialorrea y sin tos** → pensar en **epiglotitis**.
 7. Observar siempre al paciente **al menos 2–3 horas post-adrenalina** antes del alta.
-

Errores comunes

- No dar corticoide porque el cuadro es “leve”.
 - Enviar a domicilio sin observación tras adrenalina.
 - Tratar con antibióticos de rutina.
 - No educar a padres sobre signos de alarma (estridor en reposo, cianosis, retracción).
 - Intentar visualización de epiglotis en niño con dificultad respiratoria (riesgo de laringoespasma).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Crup viral = laringitis aguda subglótica**, típicamente en niños 6 meses–5 años.
2. **Causa principal:** virus Parainfluenza; produce **tos perruna, disfonía y estridor**.
3. **Tratamiento base: corticoides** (dexametasona) en todos los casos.
4. **Adrenalina nebulizada** para estridor en reposo o dificultad respiratoria.
5. **Diagnóstico clínico**; evitar manipulación de la vía aérea.
6. **Hospitalizar** si hay estridor persistente, hipoxemia o mala respuesta.
7. Pronóstico excelente; recidiva posible pero sin secuelas.